

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Perte de connaissance / Malaise

Conduite à tenir devant malaise, chute avec malaise suspecté ou perte de connaissance brève ou persistante.

Indications

- Malaise avec pâleur, sueurs, faiblesse, vertige ou confusion.
- Perte de connaissance brève avec récupération.
- Résident retrouvé inconscient ou difficilement réveillable.

Vérifications préalables

- Sécuriser l'environnement et ne pas relever précipitamment.
- Vérifier réponse à la voix/stimulation et respiration.
- Prendre glycémie capillaire et constantes si possible sans retarder l'alerte.
- Rechercher douleur thoracique, dyspnée, déficit neurologique, traumatisme.

Ne pas appliquer ce protocole

- Ne rien donner per os si trouble de conscience.
- Ne pas laisser seul après malaise ou récupération incomplète.
- Ne pas banaliser malaise avec douleur thoracique ou déficit neurologique.
- Ne pas mobiliser un résident instable.

Conduite à tenir

- Si conscient : allonger ou installer en sécurité, rassurer, surveiller.
- Si inconscient et respiration normale : position latérale de sécurité.
- Si respiration absente/anormale : protocole arrêt cardio-respiratoire.
- Prévenir médecin/IDE selon gravité et contexte.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, durée, circonstances, constantes, glycémie et récupération.
- Surveiller conscience, respiration, douleur, récurrence, traumatisme.
- Noter appels et consignes reçues.

Alerte immédiate

- Appel 15 si inconscience persistante, respiration anormale, douleur thoracique, dyspnée, déficit neurologique, convulsions ou traumatisme grave.
- Appel médical rapide pour tout malaise inexpliqué ou récidivant.

Mention de sécurité

La priorité est d'identifier l'arrêt cardiaque : inconscient + respiration absente/anormale = RCP et DAE immédiats.

Fait à :

Le : / /

Signature :